

NOTULEN RAPAT

HARI / TANGGAL

: Kamis / 07 Maret 2024

JAM

: 13.00 WIB - Selesai

ACARA

: Rapat Koordinasi Kepala Bidang Kepala Ruang

TEMPAT

: Hall Sakura

| NO | POKOK BAHASAN                 | MASALAH                                                                                                                                                                                                                                                     | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PIC                                                                            |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Tindak Lanjut<br>Komplain PKM | <div><div>1. Jadwal dokter berubah sewaktu-waktu</div><div>2. Ada kendala saat px reservasi melalui mobile jkn, respon CSO lama</div><div>3. case : diagnose px tidak sesuai, px diminta balik ke puskesmas, padahal masa rujukan masih berlaku</div></div> | <div><div>1. Ketika ada perubahan jadwal / DPJP ijin, CSO melakukan update informasi melalui social media dan unit terkait</div><div>2. Saat malam PDF bantu balas reservasi di whatsapp<ul style="list-style-type: none"><li>ketika px terkendala mobile jkn, cso membantu untuk reservasi manual</li></ul></div><div>3. pdf melakukan check data rujukan px, ketika ada kendala dapat disampaikan ke humas marketing / bu fefi untuk disampaikan ke grup jejaring (penyampaian dgn lampiran data pkm mana, kendala apa)</div></div> | <div><div>CSO, pdf, poli</div><div>Pdf, CSO</div><div>Pdf, humas</div></div>   |
| 2  | Reservasi pasien              | px sudah datang namun reservasi DPJP sudah penuh / closed                                                                                                                                                                                                   | px datang harus dilayani, komunikasi dengan dokter dikoordinasikan dengan manajemen /mod untuk komunikasi dgn dokter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mod, pdf, cso                                                                  |
| 3  | IRJA                          | E-RM Fisioterapi belum aktif                                                                                                                                                                                                                                | Programmer IT visit rumah sakit<br>Hari Sabtu 09/03/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Programmer, IRJA, kabid jangmed                                                |
| 4  | Verif                         | <div><div>1. 3 bulan terakhir, di IGD ditemukan data RM rawat jalan hilang</div><div>2. E-RM IGD belum berjalan sepenuhnya, akhirnya verif masih terima hardfile</div><div>3. penulisan saat merujuk px bayi, untuk kelengkapan klaim</div></div>           | <div><div>1. Kepala Ruang menertibkan terkait kelengkapan RM di IGD</div><div>2. Dipastikan semua memiliki akun E-RM, kepatuhan dalam penggunaan E-RM di IGD ditingkatkan. Ketika ada kendala disampaikan dan diajukan (contoh : kendala sarpras, dll)<ul style="list-style-type: none"><li>segera diajukan computer untuk dokter</li></ul></div><div>3. Saat merujuk px bayi harap bidan perujuk menuliskan rujukan, kelengkapan pengisian data diperhatikan</div></div>                                                             | <div><div>Karu IGD</div><div>IGD, Gudang Umum</div><div>IGD, Bidan</div></div> |



|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 5  | Laboratorium      | Penulisan DPJP dari IKO tidak jelas                                                                                                                                                                                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. IKO reminder ke DPJP untuk penulisan lebih baik (bisa dibaca)</li><li>2. Lab membuat data penulisan dokter yang tidak terbaca, untuk laporan</li></ol>                                                                                | IKO<br><br>Laborat                         |
| 6  | IPSRS             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya beberapa kerusakan alat tidak segera di tindak lanjut</li><li>2. Kerusakan syring pump, infus pump, terkendala sparepart mahal</li></ol>                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. BAC kerusakan segera diproses dan ditindaklanjuti perbaikan atau pengajuan</li><li>2. Ketika sparepart mahal, diajukan pembelian baru (IPSRS dan unit terkait tindak lanjut segera)</li></ol>                                         | Unit terkait dan IPSRS Atem                |
| 7  | Perbaikan pipa ac | Perbaikan membutuhkan pembongkaran namun masih ada px di ruangan                                                                                                                                                                                                                                  | Koordinasi dengan ruangan untuk jadwal perbaikan                                                                                                                                                                                                                               | Tukang, Kabid Umum                         |
| 8  | PPI               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. IPCLN pasif dalam pelaporan</li><li>2. Alur CSSD yang baru</li><li>3. alur pajanan belum berjalan</li></ol>                                                                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. kepala ruang reminder ipcln di unitnya untuk pengumpulan laporan tepat waktu</li><li>2. PPI dan CSSD membuat dan share alur yang baru segera</li><li>3. PPI Share alur pajanan kembali</li></ol>                                      | All IPCLN, PPI<br><br>PPI, CSSD<br><br>PPI |
| 9  | K3RS              | Kepatuhan pelaporan icu dan cssd masih belum berjalan                                                                                                                                                                                                                                             | Kepala ruang reminder pj unitnya untuk pelaporan k3rs                                                                                                                                                                                                                          | ICU, CSSD                                  |
| 10 | Mutu              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepuasan pasien masih kurang dalam antrian obat di farmasi</li><li>2. IKP dilaporkan ke K3</li></ol>                                                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi kembali mengenai pelayanan farmasi</li><li>2. Terkait dengan IKP harus disampaikan ke bagian mutu</li></ol>                                                                                                                  | Kabid Jangmed PJ Mutu Unit                 |
| 11 | SDM               | Kedisiplinan unit terkait dengan pengumpulan jadwal unit                                                                                                                                                                                                                                          | Jadwal dikumpulkan secara file dan hard                                                                                                                                                                                                                                        | All unit                                   |
| 12 | IRNA 2B           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum adanya ruang obat khusus IRNA 2B, jika ada lebih efisien</li><li>2. Pengunjung masih belum tertib (banyak pengunjung, berkunjung melebihi jam kunjung dll)</li></ol>                                                                               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Apakah bisa diajukan untuk pengadaan ruang obat untuk irna 2b</li><li>2. Dilakukan penertiban dan di KIE jika ditemukan pengunjung tidak tertib</li></ol>                                                                             | Manajeme n<br><br>security                 |
| 13 | CSSD Laundry      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan penemuan benda asing dalam linen (Unit IKO)1</li><li>2. Kekurangan stok kasa, adanya pelaporan dari farmasi ada unit yg ambil stok kasa IKO</li><li>3. Ada unit yang butuh ukuran kasa yg spesifik dan berbeda dari yang diberikan</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. IKO memastikan untuk pengiriman linen (bersih dari alat)</li><li>2. Unit lebih tertib lagi dalam pengambilan kasa, disesuaikan peruntukannya</li><li>3. Unit pengajuan sesuai kebutuhan dilampiri spesifikasi yg dibutuhkan</li></ol> | IKO<br><br>All unit<br><br>All unit        |
| 14 | Farmasi           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Px diresepkan ulang, obat mana saja yang diberikan di pengambilan kedua</li><li>2. Ketika px datang kembali pengambilan obat, apakah ikut</li></ol>                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Obat kronis saja yang diberikan</li><li>2. Bulan kedua tidak diikuti inacbg, diikuti apotek online</li></ol>                                                                                                                          | Kains farmasi<br><br>Farmasi               |



|    |           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    |           | 3. Papanisasi farmasi sampai mana<br><br>4. Pemenuhan SDM di farmasi<br><br>5. Serah terima obat pagi sudah sesuai, namun sore masih belum                                  | 3. Follow up ke PKRS untuk pemenuhan papanisasi di farmasi<br>4. SDM pemenuhan dan informasi ke kains progress pemenuhannya<br>5. Ditertibkan kembali untuk alur sertim obat                                                                                                                | PKRS<br><br>SDM<br><br>Farmasi         |
| 15 | IGD       | 1. Pemenuhan stop kontak untuk IGD lorong<br><br>2. Microfone di IGD belum aktif<br><br>3. Security shift malam stnby dmna, security kurang tanggap ketika IGD ramai pasien | 1. Pemenuhan dengan kabel olor dan dirapihkan agar tidak mengganggu pelayanan<br>2. IPSRS segera tindak lanjut target minggu ini selesai<br>3. Security standby di depan IGD, dan lebih tanggap lagi dalam pengamanan di RS. Peletakkan computer dikoord dengan                             | IPSRS<br><br>IPSRS<br><br>Security     |
| 16 | Radiologi | 1. Specimen ttd dr dani sp.rad harus ada di billing simrs, ketika di print tidak muncul ttdnya<br><br>2. Hasil bacaan radiologi                                             | 1. Diprogress untuk spesimen ttd by simrs dr dani, Kendala cetak specimen diatasi dengan stemple ttd<br>2. Karu radiologi memiliki data berpa banyak bacaan yang diulang oleh dr dani                                                                                                       | Radiologi, programmer<br><br>radiologi |
| 17 | MOD       | 1. Terkait penerbitan akte, bebrapa px complain karena menunggu<br>2. Form A form B dijalankan, dokter ruangan juga disosialisasikan                                        | 1. Edukasi ke px untuk pengurusan 1,5 bulan<br>2. MOD sosialisasikan ked r ruangan                                                                                                                                                                                                          | PDF<br><br>MOD                         |
| 18 | HIV       | Terkait pajanan, pj hiv belum ter cc sehingga pelaporan ke eksternal blm maksimal                                                                                           | Perbaiki alur panajan, ditambah pelaporan ke PJ HIV                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| 19 | Keuangan  | 1. Ct-scan tidak diinput, sehingga saat penagihan terkendala<br><br>2. Pemberian vaksin tidak sesuai                                                                        | 1. Ruangan wajib menginput semua tindakan lengkap yang diberikan ke px<br>2. Diperhatikan kembali untuk pemberian vaksin, dan ketika ada perubahan diinformasikan ke farmasi dan kasir<br>- ketika ada permintaan dari IRJA segera order ke farmasi agar segera pengadaan sesuai permintaan | All ruangan<br><br>Farmasi, IRJA       |

Direktur RS Prima Husada Sukorejo



dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS

Notulis

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Arindha Rahma Putri, S.Psi



DOKUMENTASI

